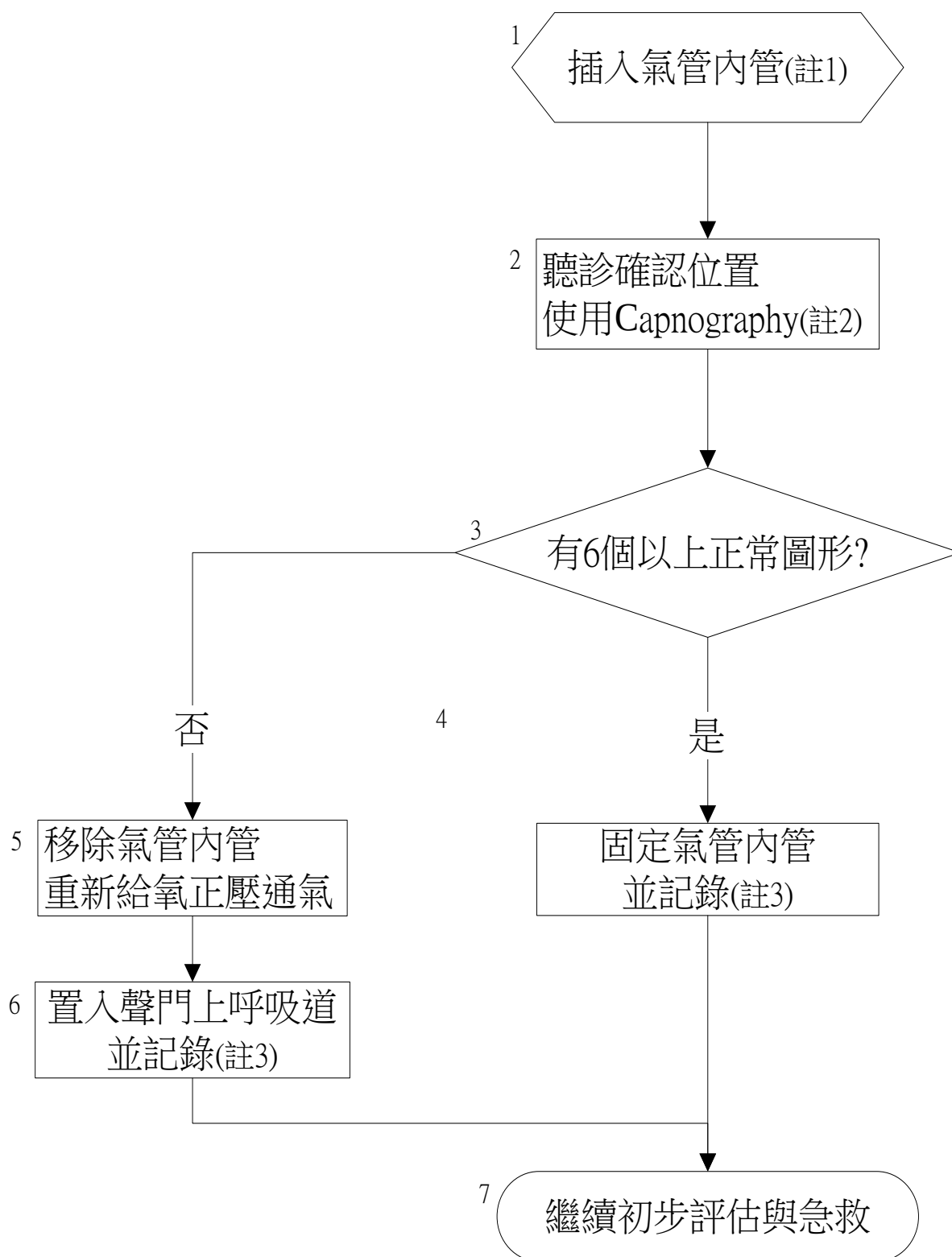


A1 P 成人氣管內管插管

程 序



要 旨

- 一、本程序僅限 EMTP 操作。
- 二、雖然氣管內管插管與其它進階呼吸道（如 LMA）在許多狀況下急救成效類似，但某些情形（例如咽喉水腫、上呼吸道阻塞、氣切病人等）仍是傷病患氣道處理的最佳方式。
- 三、現場操作氣管內管插管應特別注意三件事：（1）勿影響 CPR 品質、（2）插管後務必確認氣管內管位置正確、（3）搬運過程勿造成氣管內管移位。

註 解

註1>

一、符合下列適應症時，即建議使用本程序：

- （一）心肺功能停止，或呼吸停止。
- （二）*意識不清，無法保護呼吸道暢通，且血氧濃度經過 BVM 正壓呼吸後仍未達 85%，且有休克症狀或瀕死式呼吸者（「附註」須於備有潮氣末二氧化碳監測設備（Capnography）實施插管位置確認之前提下方可施行）。
- （三）*上呼吸道阻塞。
- （四）*為連接侵入型機械通氣（呼吸器）。

二、禁忌症：

- （一）明顯死亡（請參考【附錄 I 不施行心肺復甦術程處置原則】）
- （二）重病末期病人已預立「不施行心肺復甦術意願書」或「選擇安寧緩和醫療意願書」

三、注意事項：

- （一）嘗試氣管內管插管，至多 2 次。插管失敗，改置入聲門上呼吸道(SGA)。
- （二）插管時間應小於 30 秒。
- （三）插管之間或插管失敗後應給予袋瓣罩（Bag-Valve-Mask）正壓通氣給氧。
- （四）插管後，應評估確認氣管內管位置，包括初級確認及次級確認二種技術。初級確認包括：插管時看到聲帶並從中插入，用聽診器確認 5 點位置，2 側胸部有擴張，氣管內管有水氣；次級確認：使用 Capnography 或使用食道偵測器（EDD）。
- （五）移動傷病患後、運送傷病患途中及到院後，應再次評估氣管內管位置。

註2>



- 一、現場狀況許可，氣管內管放置後，使用Capnography並給予通氣測試6次(同時使用聽診器確認位置)。
- 二、若現場無法使用Capnography時，得先以EDD測試(擠壓EDD球體使成負壓狀態，再將其接上氣管內管接合器上，觀察EDD球體是否回復原狀)，俟搬運傷病患上救護車後再使用Capnography。

註3>

將傷病患搬運至救護車過程中，為防止氣管內管(或SGA)滑脫，可暫時分離BVM(或Capnography)或使用延長蛇管，惟至救護車上應重新接合，並記錄ETCO₂數值與圖形。